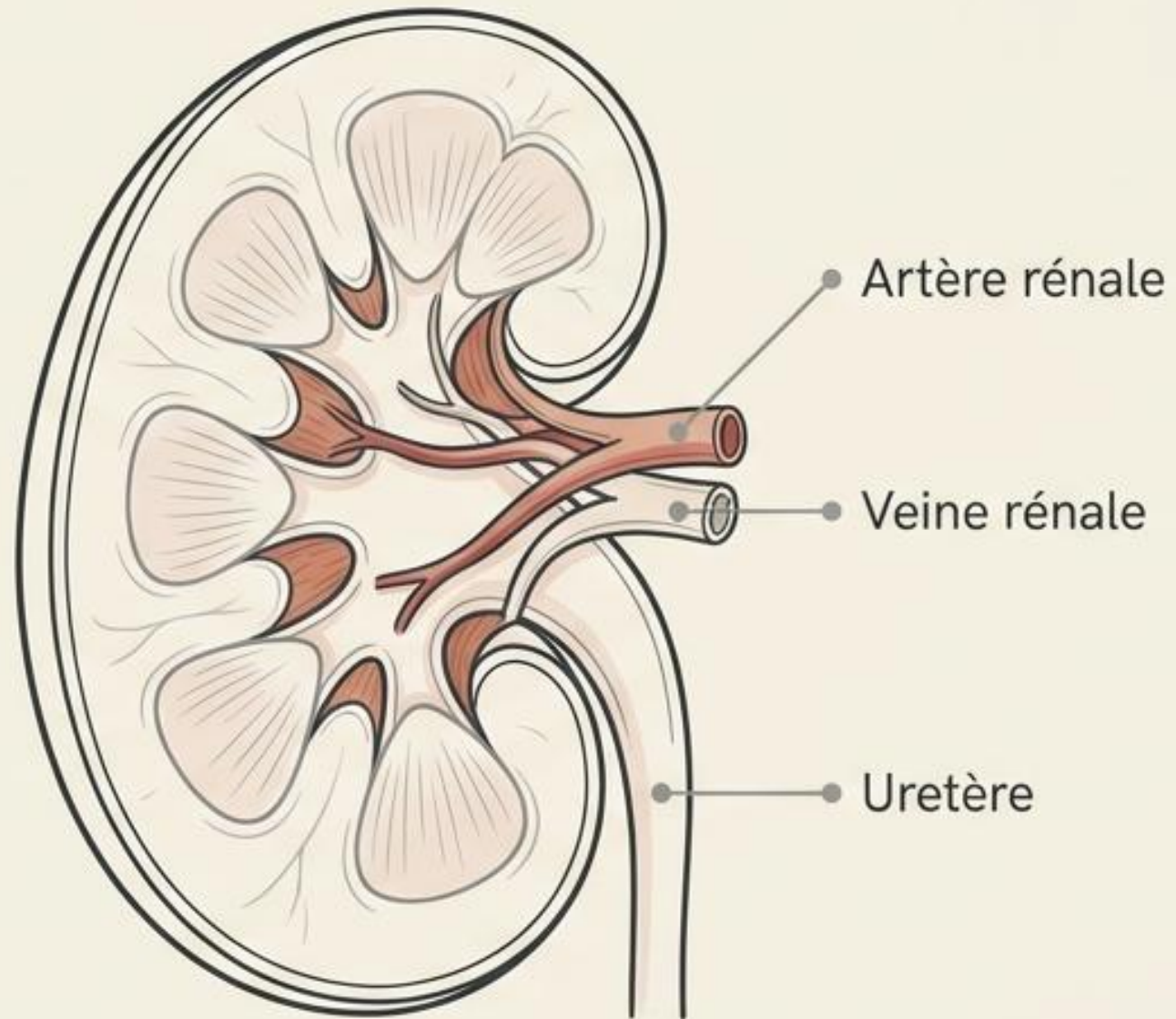


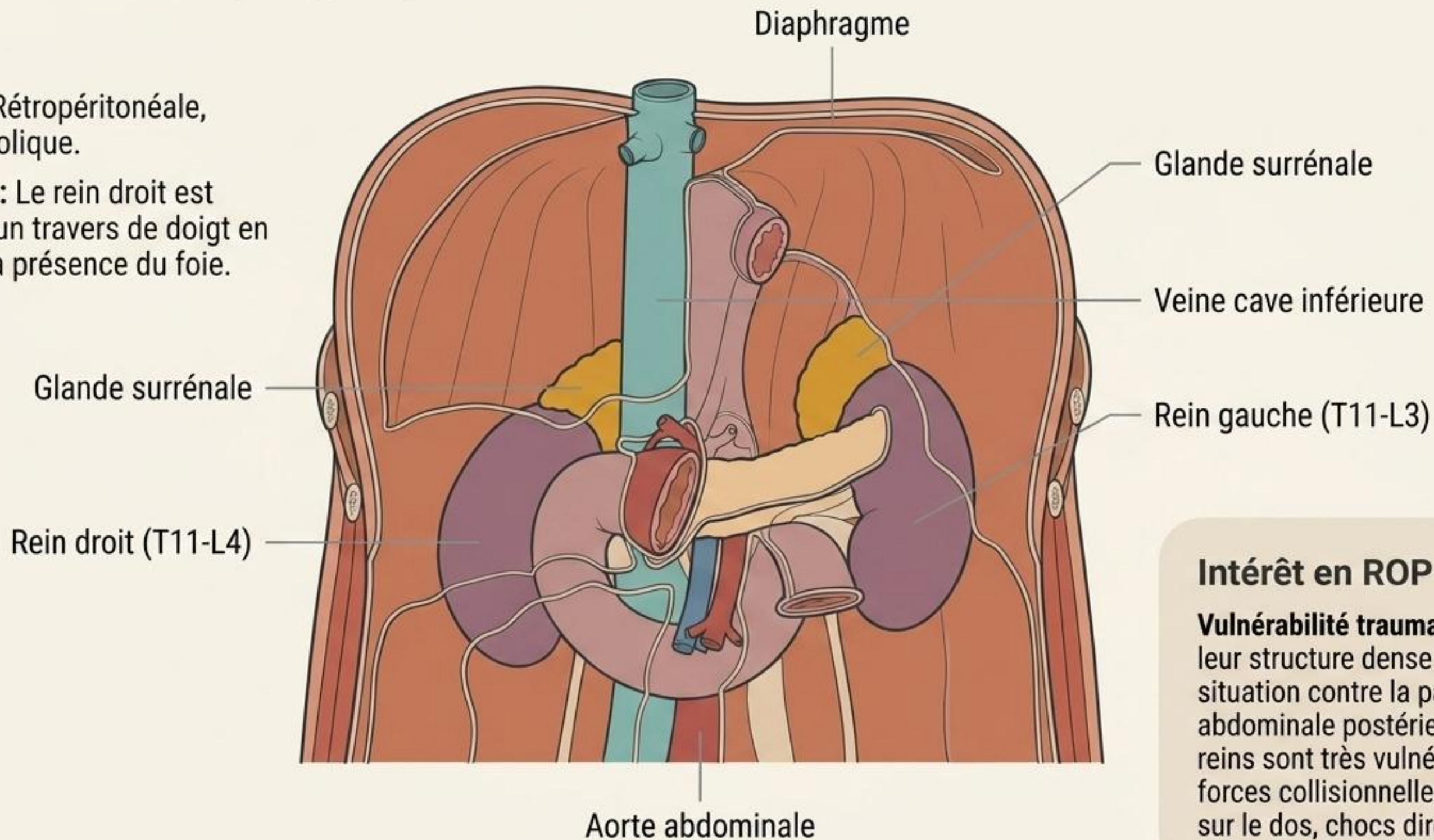
Chapitre 16 : Les Reins

Structure, Fonction et Sens Clinique en ROP



Situation et Topographie

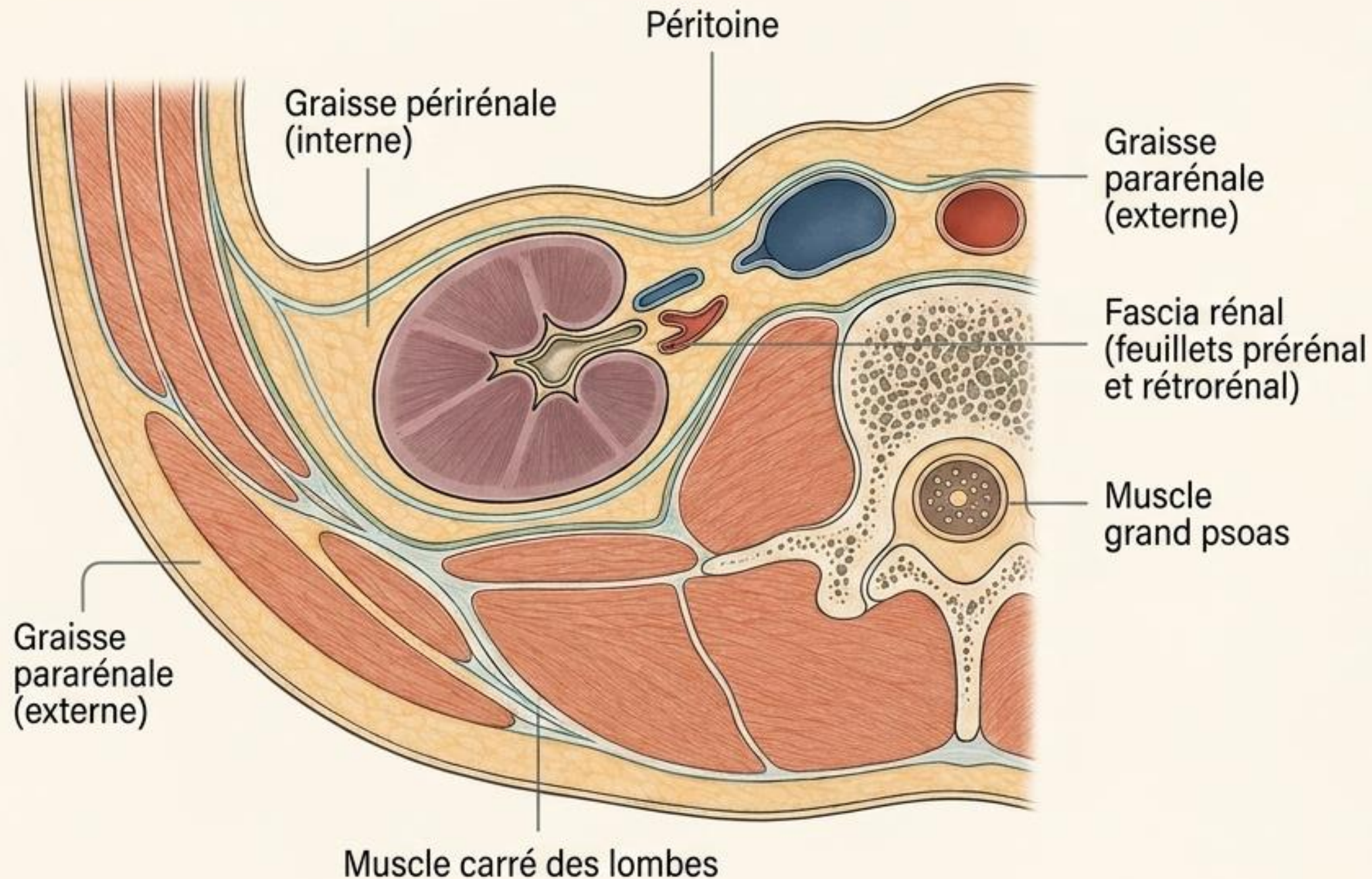
- **Position** : Rétropéritonéale, sus-mésocolique.
- **Asymétrie** : Le rein droit est plus bas d'un travers de doigt en raison de la présence du foie.



Intérêt en ROP

Vulnérabilité traumatique : Par leur structure dense et leur situation contre la paroi abdominale postérieure, les reins sont très vulnérables aux forces collisionnelles (chutes sur le dos, chocs directs).

La Loge Rénale et ses Enveloppes



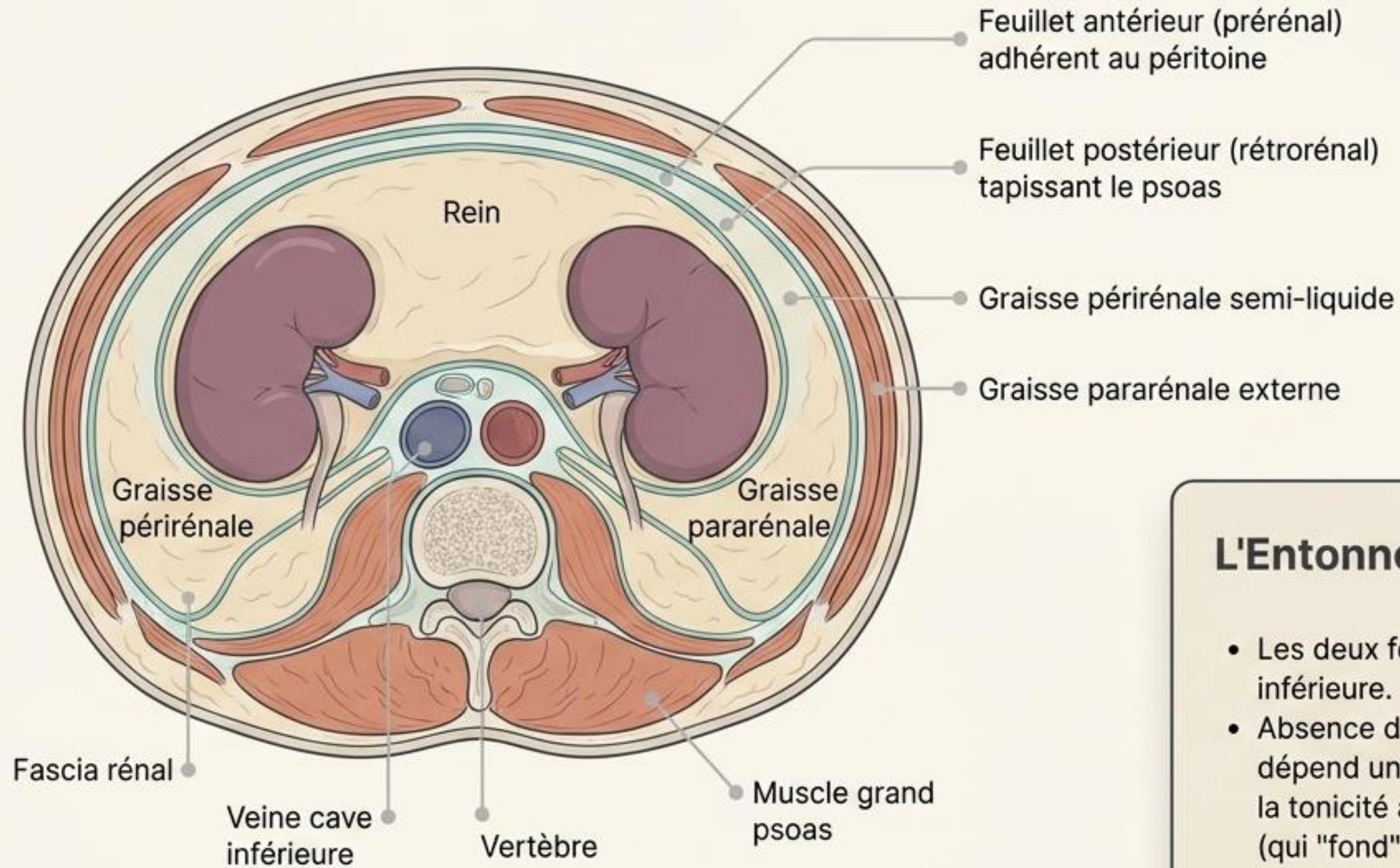
Moyens de fixité

- Les reins n'ont ni ligaments ni mésos.
- Leur maintien dépend de : l'aspiration thoracique, l'aimantation diaphragmatique, la tonicité abdominale et le volume des graisses péri/paranéphriques.

Intérêt en ROP

Dynamique régionale : Les deux loges rénales sont abordées ensemble. Leurs fascias et liens diaphragmatico-lombaires participent à une dynamique commune. Une perte de graisse (amaigrissement) entraîne un glissement du rein vers le bas (ptose).

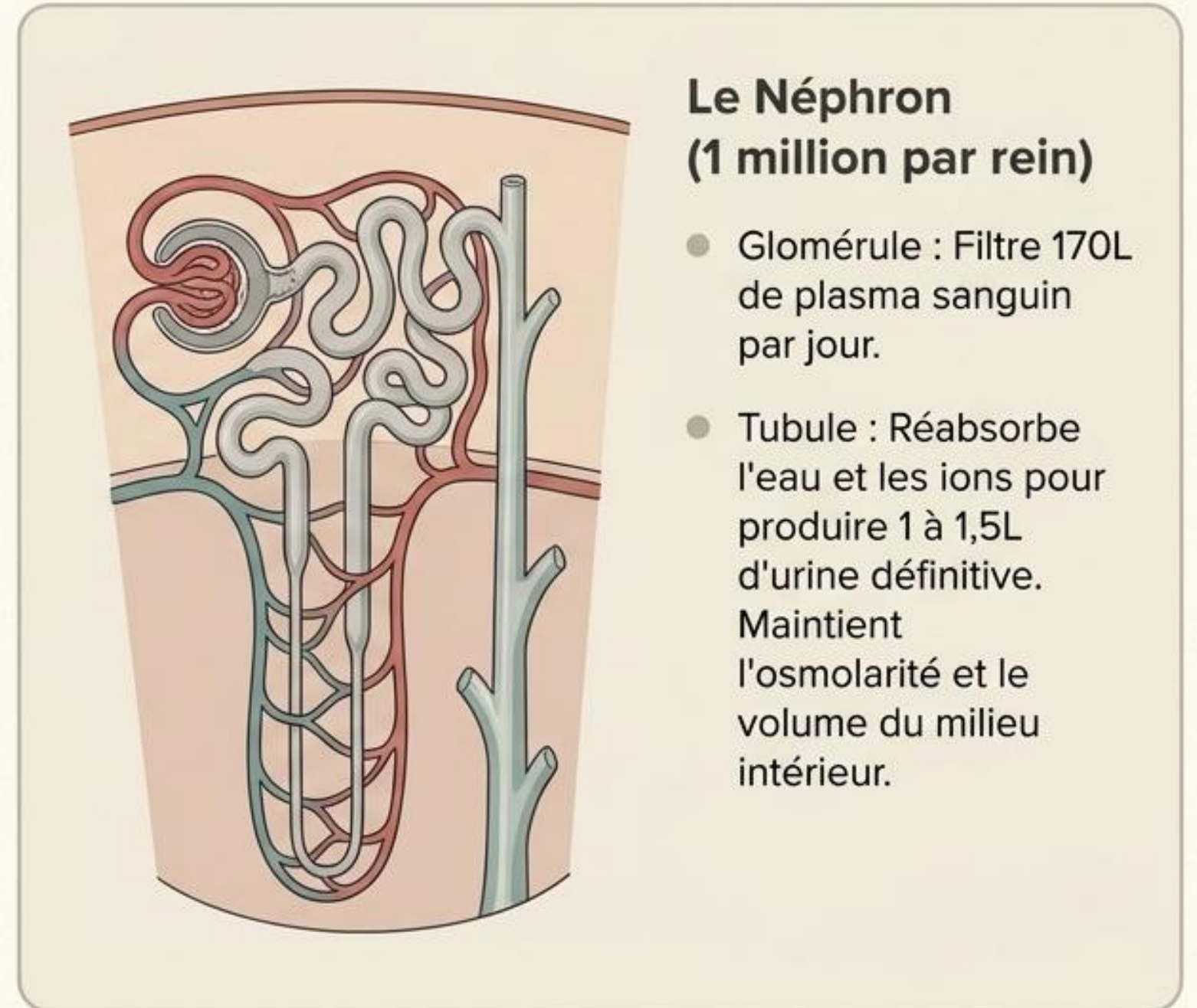
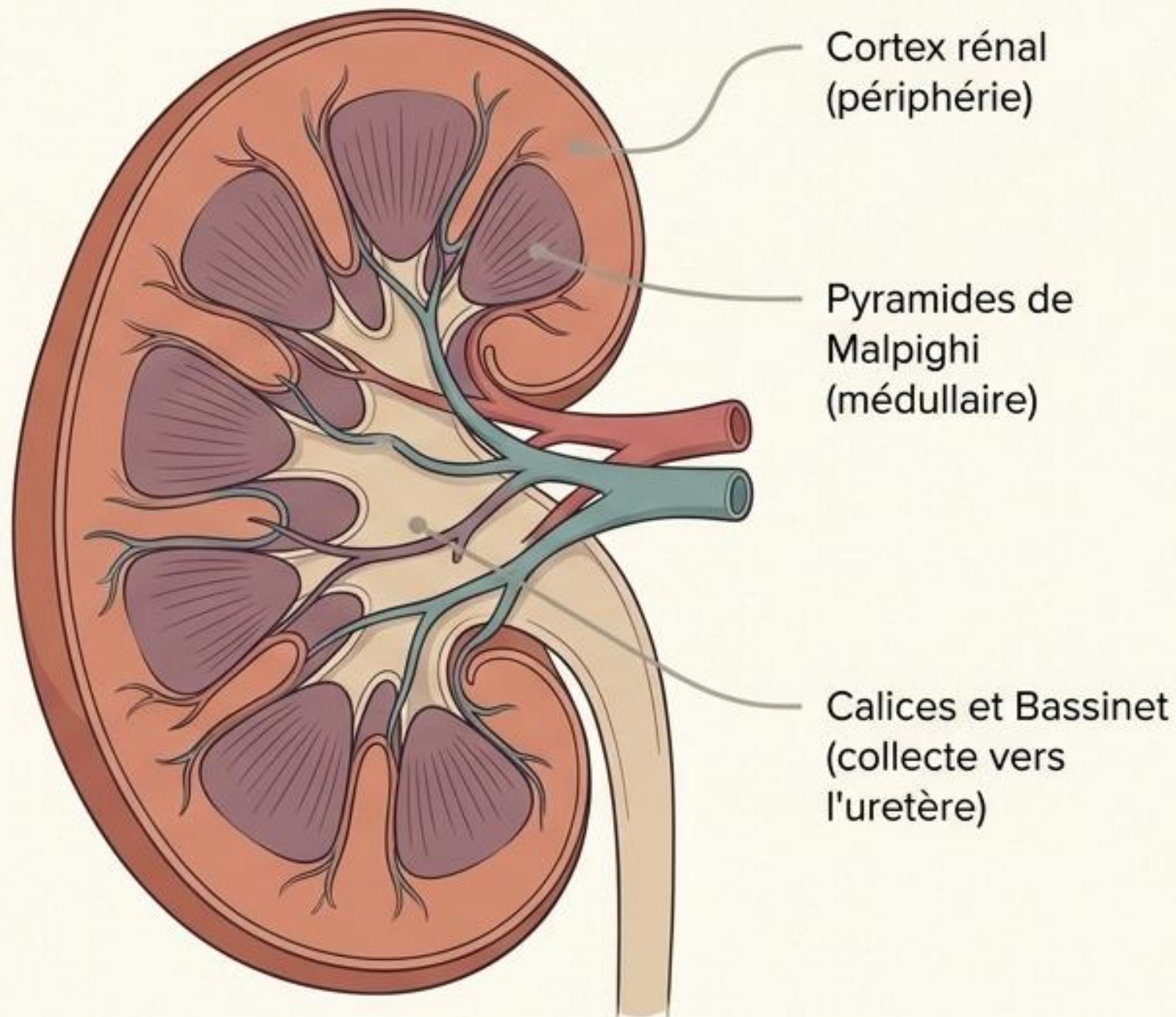
L'Enveloppe Fasciale : Une Loge Ouverte



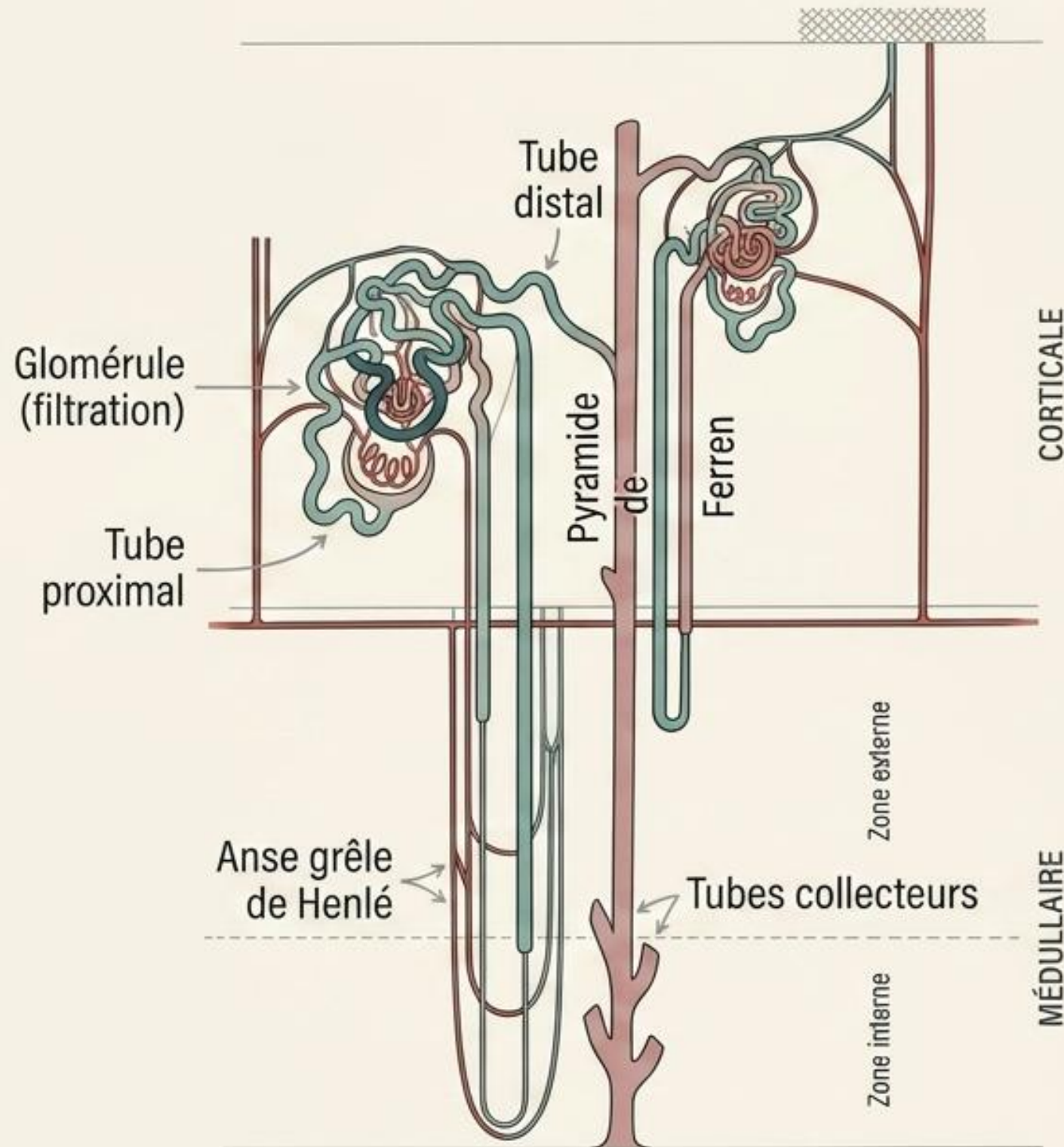
L'Entonnoir Ouvert en Bas

- Les deux feuillets ne se rejoignent pas à la partie inférieure.
- Absence de ligaments suspenseurs : la fixité dépend uniquement de l'aspiration thoracique, de la tonicité abdominale et du volume de graisse (qui "fond" lors d'amaigrissements importants).

Architecture Interne et Unité Fonctionnelle

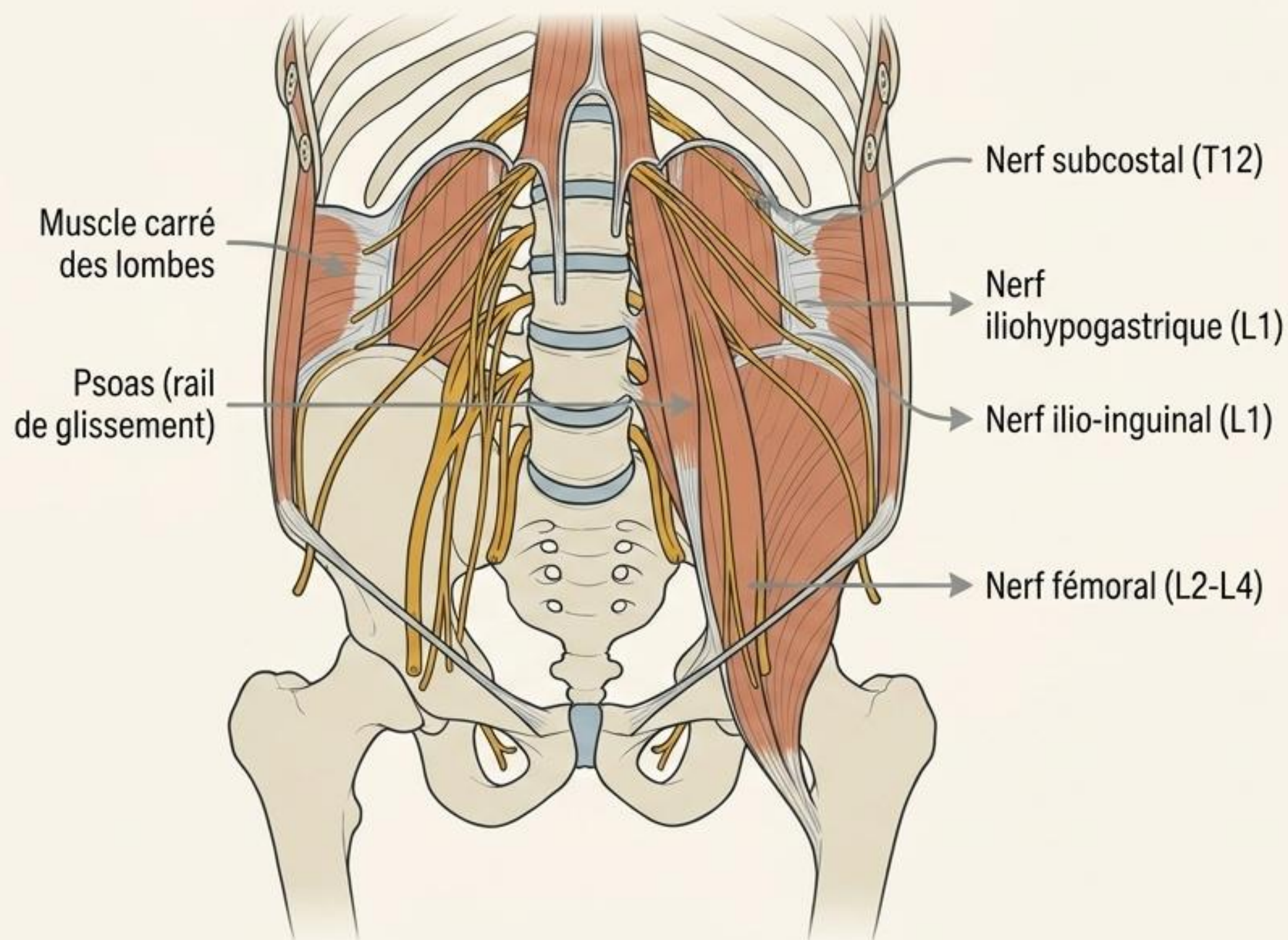


Le Néphron : L'Unité Fonctionnelle



- **Densité** : ~1 000 000 de néphrons par rein.
- **Double fonction homéostasique** :
 1. **Glomérule** : Filtre le plasma sanguin (170L/jour d'urine primitive).
 2. **Tubule** : Réabsorbe l'eau, le sodium et les minéraux essentiels, et sécrète les déchets (1 à 1,5L/jour d'urine définitive).

Rapports Dorsaux et Plexus Lombaire



Intérêt en ROP

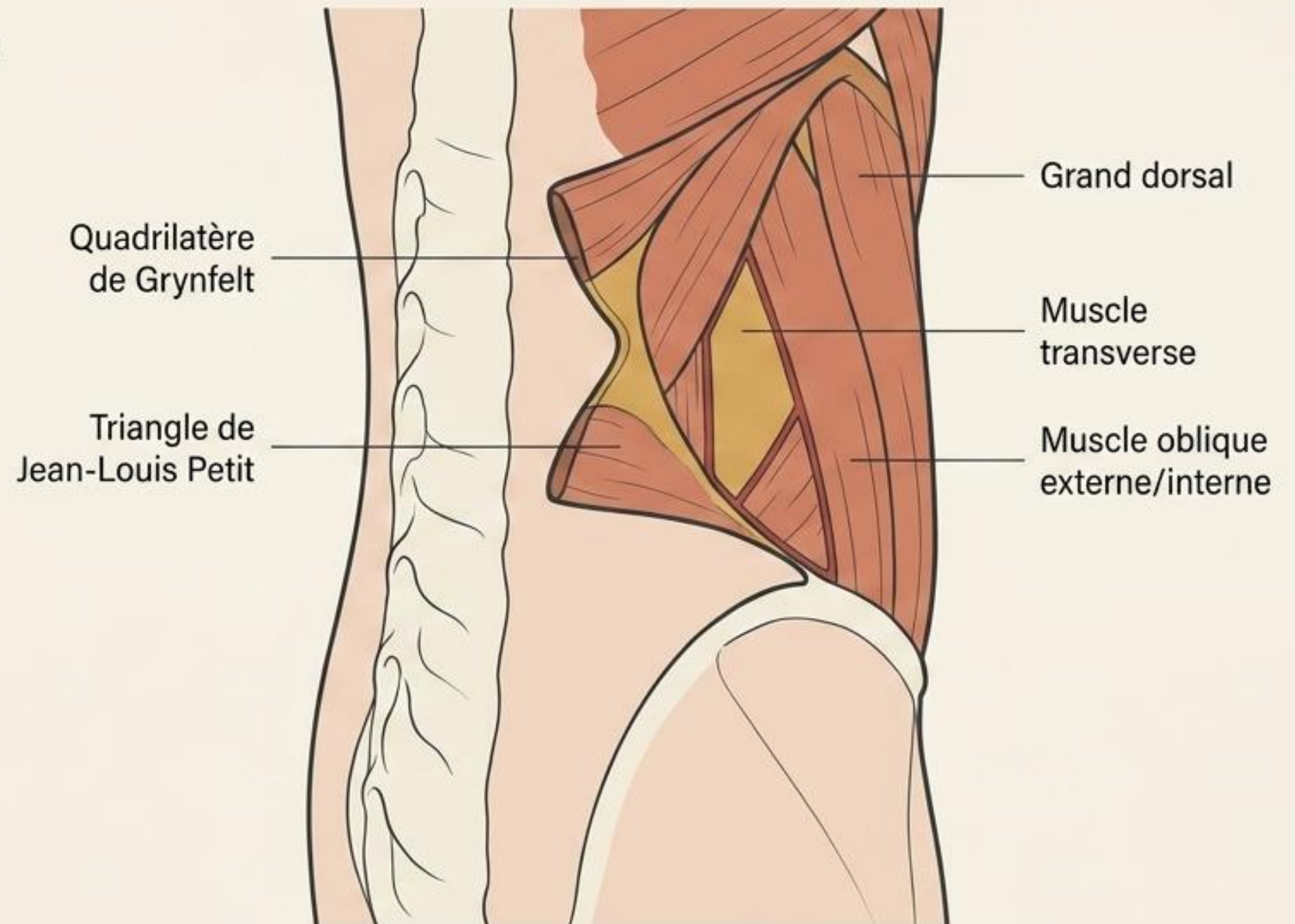
- **Traumatisme et Mobilité :** Un traumatisme ancien de la fosse lombaire peut se traduire par une fixation postérieure de la loge rénale.
- **Irradiations nerveuses :** La perte de mobilité locale entraîne souvent l'irritation des nerfs du plexus lombaire cheminant dans la graisse pararénale (douleurs profondes du flanc, irradiations pelviennes ou crurales).

Fenêtres Thérapeutiques : Les Zones de Faiblesse

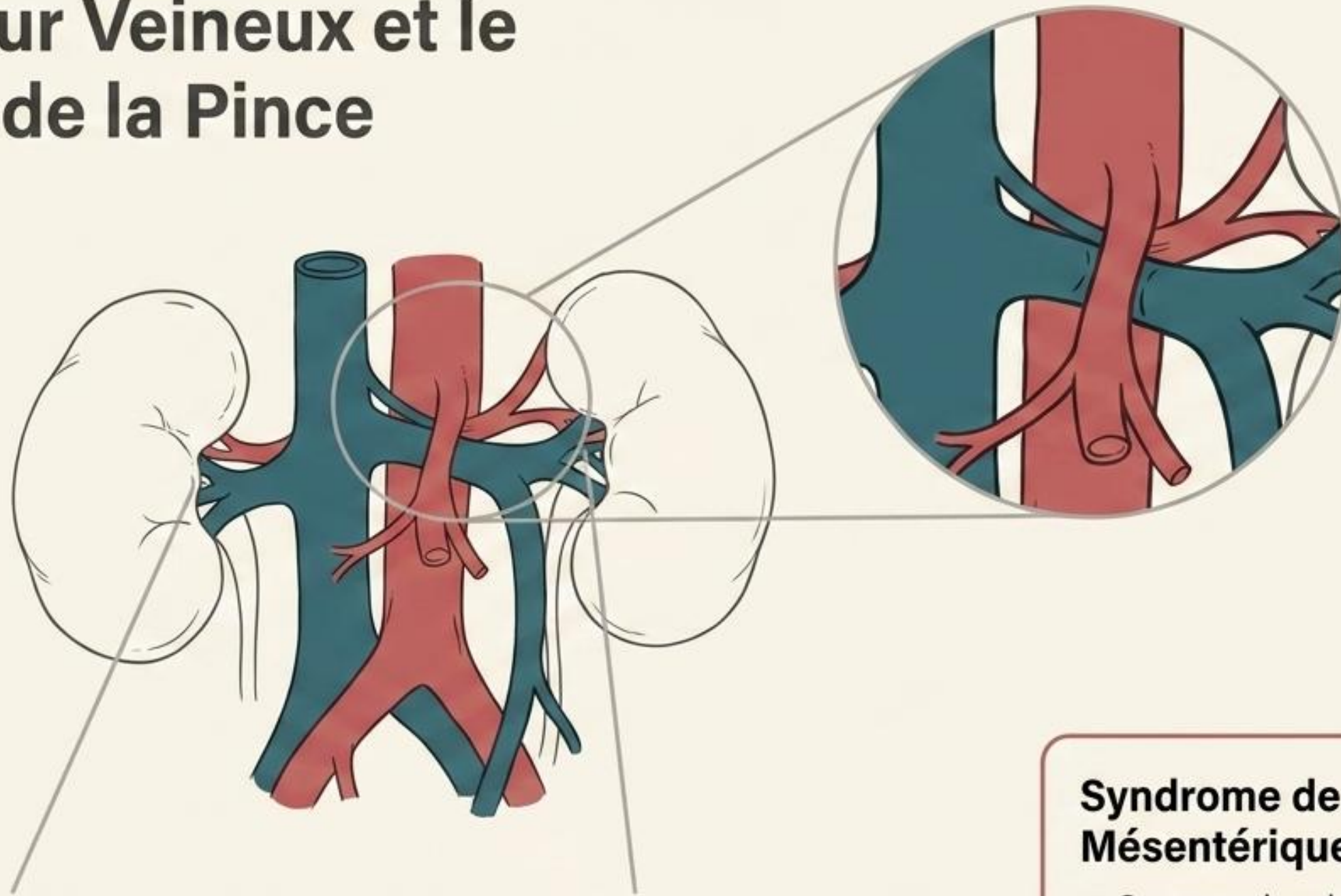
Accès direct :

Ces deux régions de la fosse lombaire sont dépourvues de faisceaux musculaires obliques.

Voie d'abord : Elles permettent d'aborder le rein sans grande interposition de tissus mous, en contact direct avec le muscle transverse et, indirectement, le plexus lombaire.



Le Carrefour Veineux et le Syndrome de la Pince



Zone de
Compression
(Nutcracker)

Veine Rénale Droite

Courte, abouchement direct dans
la veine cave inférieure.

Veine Rénale Gauche

Plus longue, reçoit la veine
gonadique (spermatique/ovarienne)
et la veine lombaire gauche.

Syndrome de la Pince Aorto-Mésentérique (Nutcracker)

- Compression de la veine rénale gauche entre l'aorte et l'artère mésentérique supérieure.
- Lecture ROP : Provoque une congestion pelvienne gauche, des varicocèles, et une pesanteur lombo-génitale gauche.

Asymétrie Clinique : Rein Droit vs Rein Gauche



Rein Droit

Identité :

Le 'Rein Digestif' (rapport avec le foie et le côlon ascendant).

Mécanique :

Tendance marquée aux ptoses et fixations antérieures. Les spasmes imitent parfois l'appendicite.

Émotionnel :

Trop-plein émotionnel du foie ; colère intense refoulée, désir de dominer freiné par la peur.



Rein Gauche

Identité :

Le 'Rein Génital' (rapport avec le système veineux gonadique).

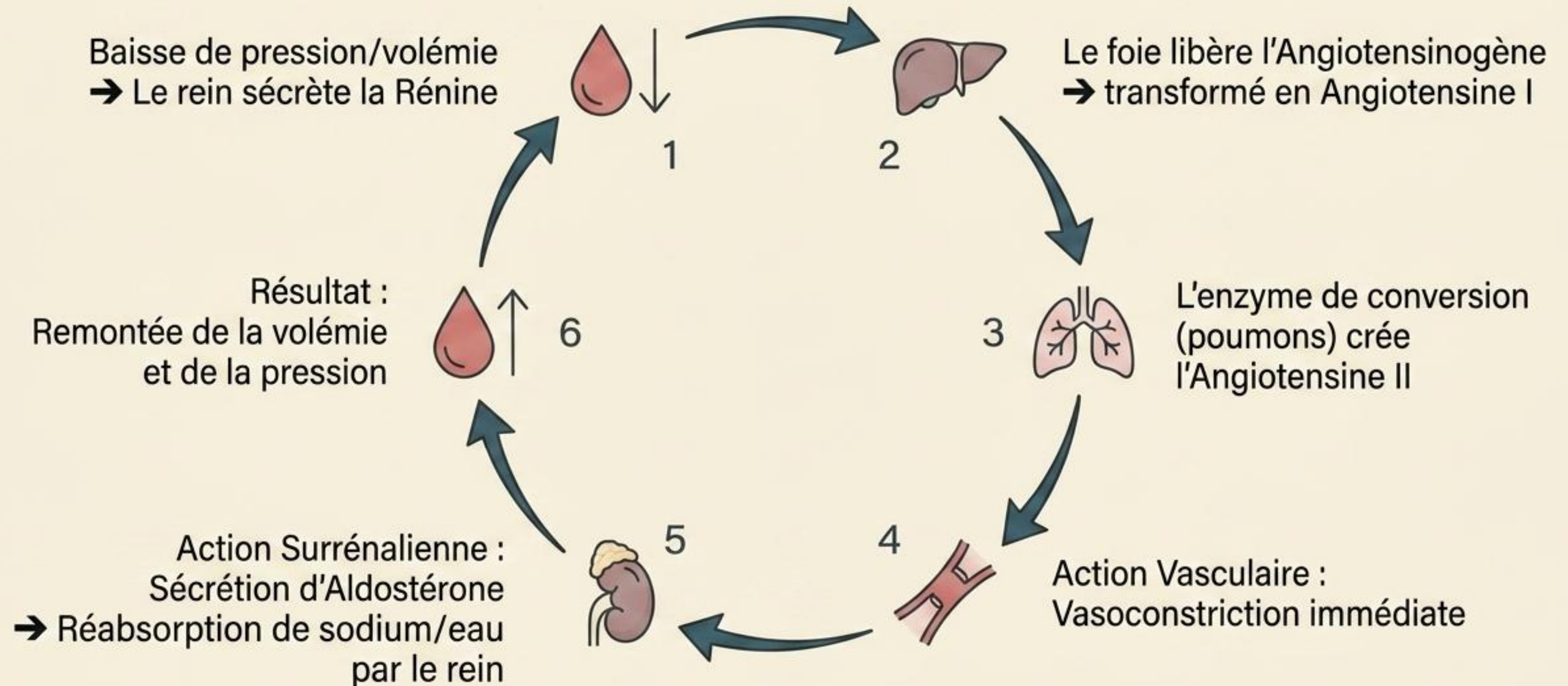
Mécanique :

Tendance aux fixations postérieures (traumatismes). Problèmes circulatoires locaux (varicocèles, règles douloureuses).

Émotionnel :

Organe de la génitalité et des racines ; peur profonde, existentielle, peur de donner la vie ou d'être abandonné.

Régulation de la pression artérielle (Système SRAA)



L'équilibre acido-basique et l'impact nutritionnel

Le rein tamponne l'acidité (pH 7.4) en excréant H^+ et retenant HCO_3^- .
L'acidose persistante entraîne inflammation, déminéralisation et stress.



Aliments Acidifiants

- Sucre (surtout à jeun)
- Alcools
- Graisses animales
- Viandes rouges, Fritures



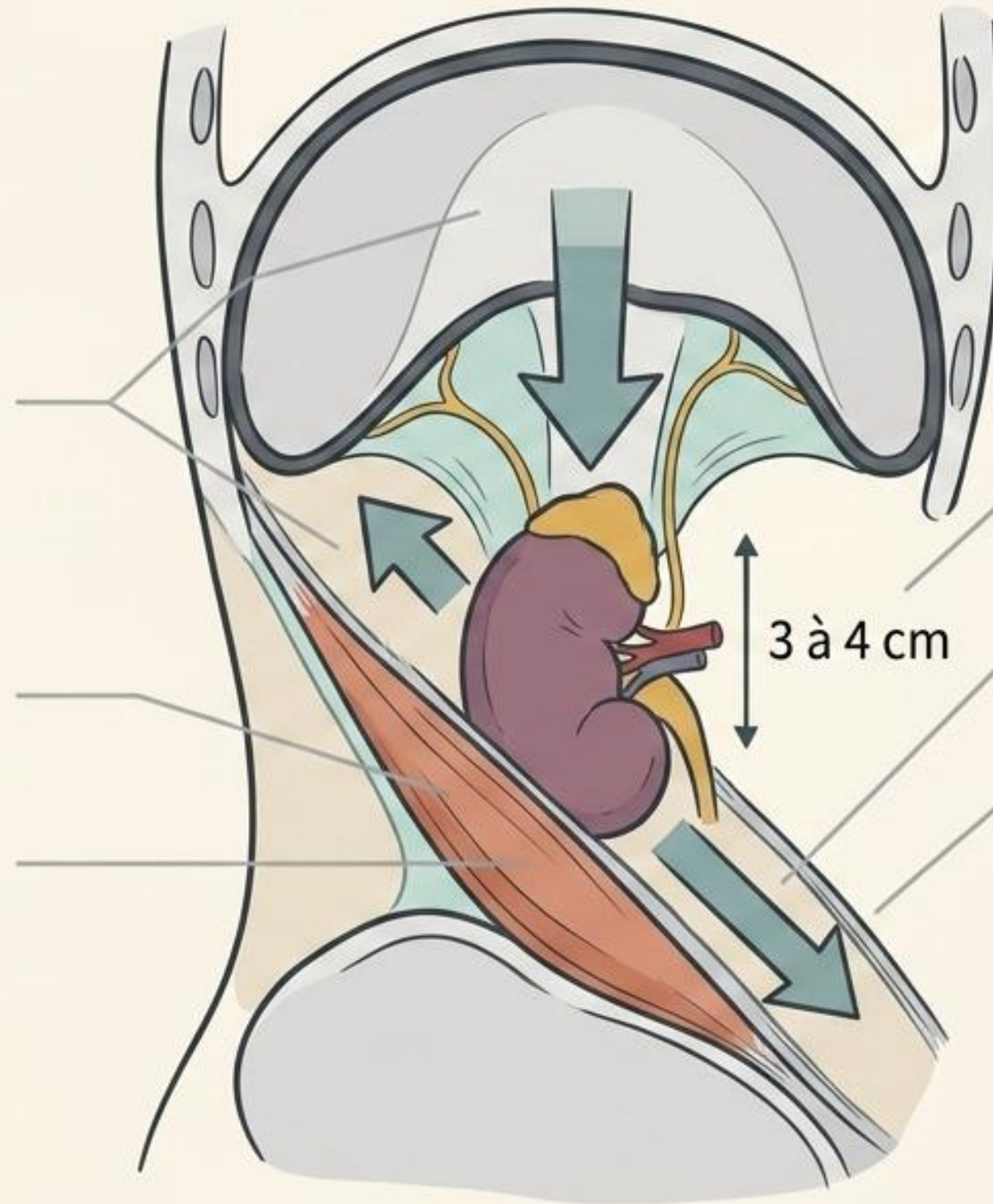
Aliments Alcalinisants

- Pomme de terre
- Oignon / Ail
- Carotte / Chou
- Amande / Citron (en petite quantité)

Dynamique Respiratoire et Motilité

Mobilité

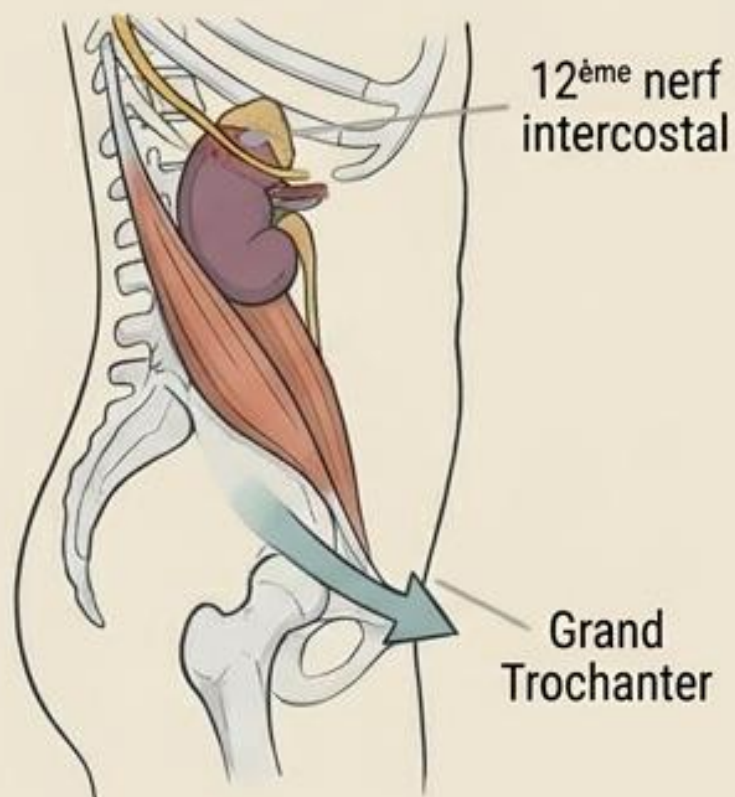
- Déplacement de 3 à 4 cm sur le rail du psoas (caudalement et latéralement).
- **Moteur** : Le diaphragme (inspiration).
- **Répétition** : 20 000 fois par jour.



Motilité

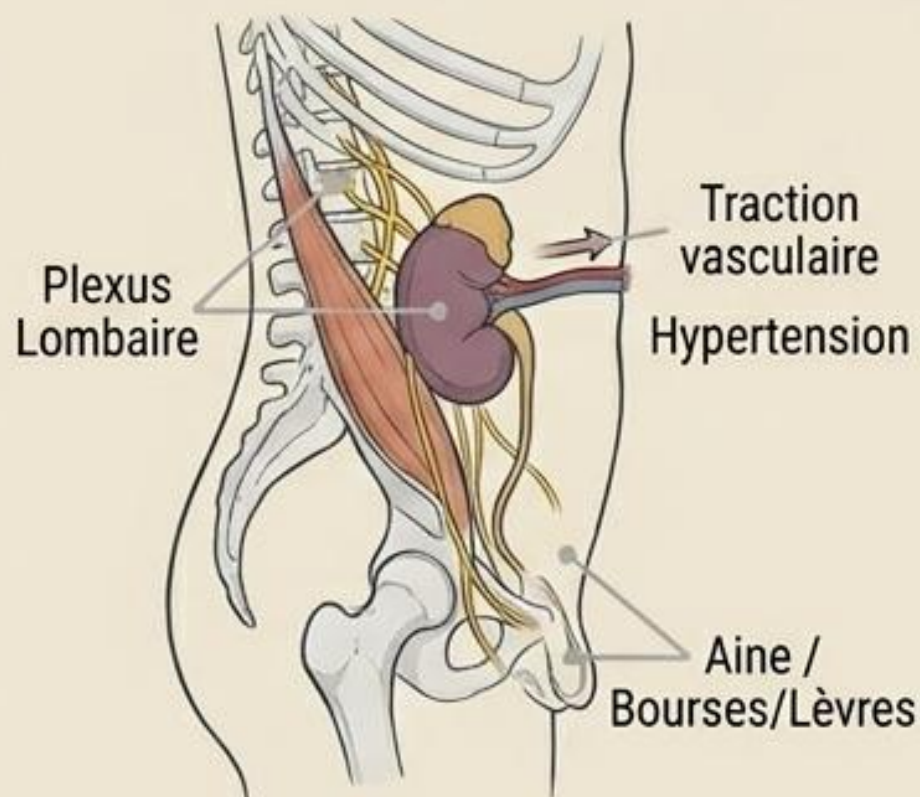
- Mouvement intrinsèque et autonome.
- **Rythme** : 7 cycles par minute.
- **Vecteur** : Descente à l' 'inspir' tissulaire, remontée à l' 'expir'.

Pathologie Mécanique : Les 3 Degrés de Ptose



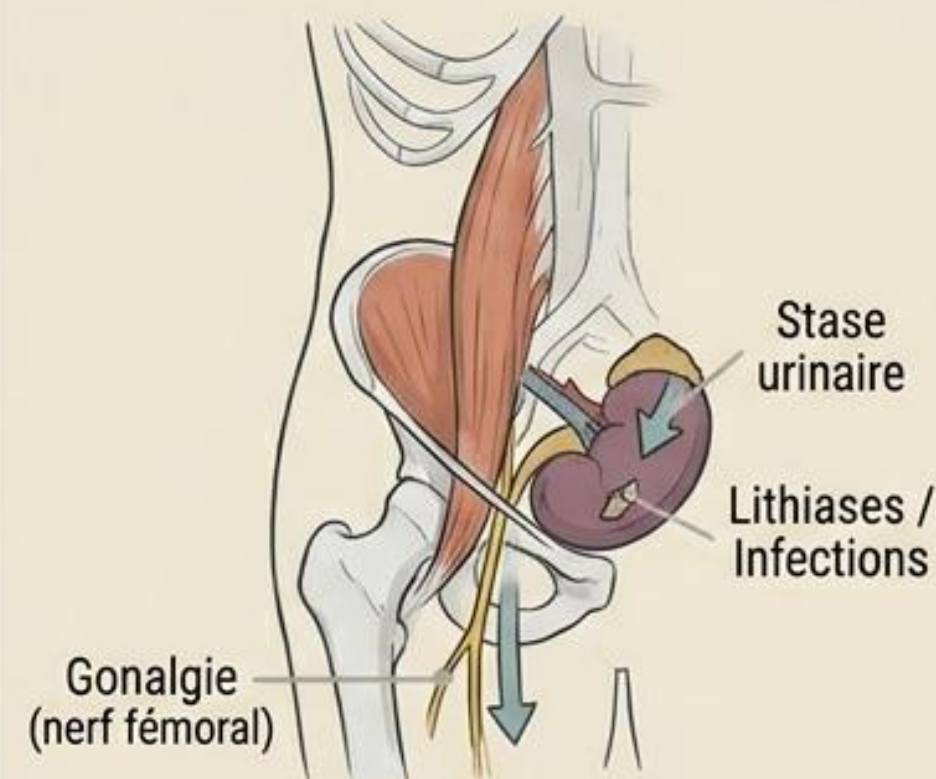
1^{er} Degré (Rein Intercostal)

Irritation du 12^{ème} nerf intercostal.
Irradiation vers le grand trochanter,
difficulté à respirer à fond.



2^{ème} Degré (Rein Abdomino-génital)

Irritation du plexus lombaire.
Douleurs à l'aine, aux bourses/lèvres.
La traction vasculaire peut créer
une hypertension.



3^{ème} Degré (Rein Fémoral / Pelvien)

Rein luxé, bloqué contre le psoas.
Gonalgie (nerf fémoral) sans
traumatisme, stase urinaire favorisant
lithiases et infections.

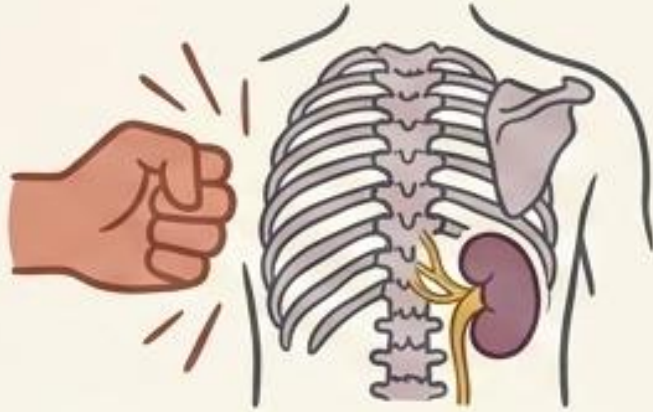
Pathologie Mécanique : La Ptose Rénale

Perte de fixité, perte de contact diaphragmatique et glissement le long du psoas.

1er Degré (Rein 'Intercostal')	Nerf irrité : 12e nerf intercostal.	Symptômes : Irradiation vers le grand trochanter. Le patient se tient le flanc, supporte mal la toux et l'inspiration profonde.
2e Degré (Rein 'Abdomino-génital')	Nerfs irrités : Iliohypogastrique, ilioinguinal, cutané fémoral.	Symptômes : Rotation externe du rein. Irradiations bas-ventre, grandes lèvres / bourses, face externe de la cuisse. Risque d'hypertension artérielle par traction vasculaire.
3e Degré (Rein 'Fémoral' ou 'Pelvien')	Nerf irrité : Nerf fémoral.	Symptômes : Luxation complète (rotation médiale). Gonalgie sans traumatisme, spasme du psoas. Coude urétéral favorisant lithiases et infections urinaires inexplicables.

Fixations Tissulaires et Lignes Rouges

Lecture Mécanique



Fixations Postérieures (Rein gauche dominant)

- Chutes sur le dos, chocs directs, fractures vertébrales. Fibrose de la graisse pararénale.



Fixations Antérieures (Rein droit dominant)

- Amaigrissement, hypotonie, suites d'appendicectomie.

Diagnostics d'Exclusion - Référence Médicale Obligatoire

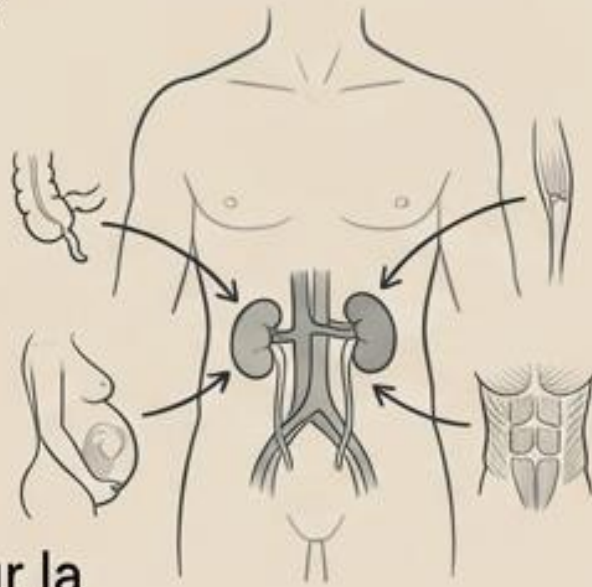
- Hématurie (urines colorées)
- Fièvre et frissons
- Douleurs de flanc nocturnes réveillantes
- Masse palpable
- Apparition soudaine d'un varicocèle
- Colique néphrétique aiguë

Fixations Tissulaires : Perte de Mobilité

Le **rein** a une amplitude normale de 3 à 4 cm lors de la respiration (20 000 fois/jour). Sa fixation abolit ce mouvement.

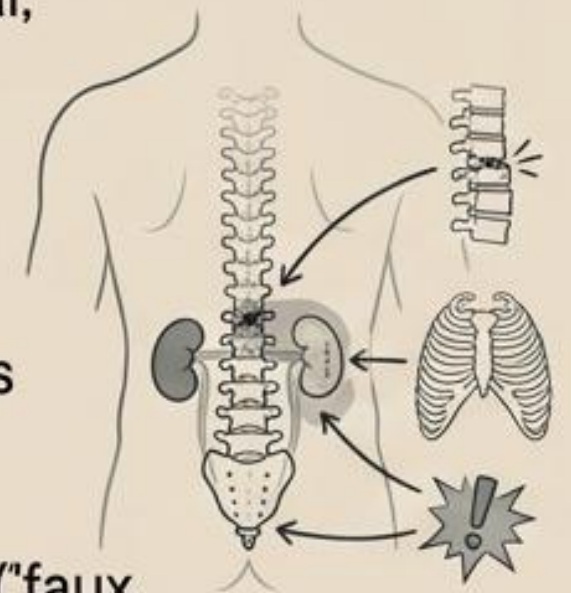
Fixations Antérieures (Dominance Rein Droit)

- Causes typiques : Séquelles d'appendicectomie, grossesse, accouchement, hypotonie abdominale, toux chronique.
- Profil : Concerne davantage les femmes.
- Conséquence : Contraintes sur la fosse lombaire droite, la veine cave et le plexus lombaire.



Fixations Postérieures (Dominance Rein Gauche)

- Causes typiques : Chute sur le dos/coccyx, traumatisme costal, fracture vertébrale (Th12-L2). Fissuration de la graisse pararénale.
- Profil : Concerne davantage les hommes (chocs directs).
- Conséquence : Lumbago aigu ("faux mouvement"), compression sévère du plexus lombaire gauche.



Approche ROP : Lecture Émotionnelle

Les reins expriment le désir refoulé, la tristesse existentielle, et les conflits parentaux.

Rein Droit (Le 'Rein Digestif')

Thématique : Organe de la "colère intense refoulée" (remontant à la petite enfance).

Dynamique : Fusion ou opposition totale avec la mère.

Expression : Celui qui veut dominer mais qui a peur de dominer. Sert de 'trop-plein' émotionnel au foie.

Rein Gauche (Le 'Rein Génital')

Thématique : Le 'moi génétique'. Organe de la "peur profonde", essentielle, au fond de soi (peur de la violence, de l'abandon).

Dynamique : Lien aux racines et au potentiel de transmettre la vie.

Expression : Refoulement important et inhibition du développement personnel. C'est l'organe de la puissance profonde de l'être.

Approche ROP :

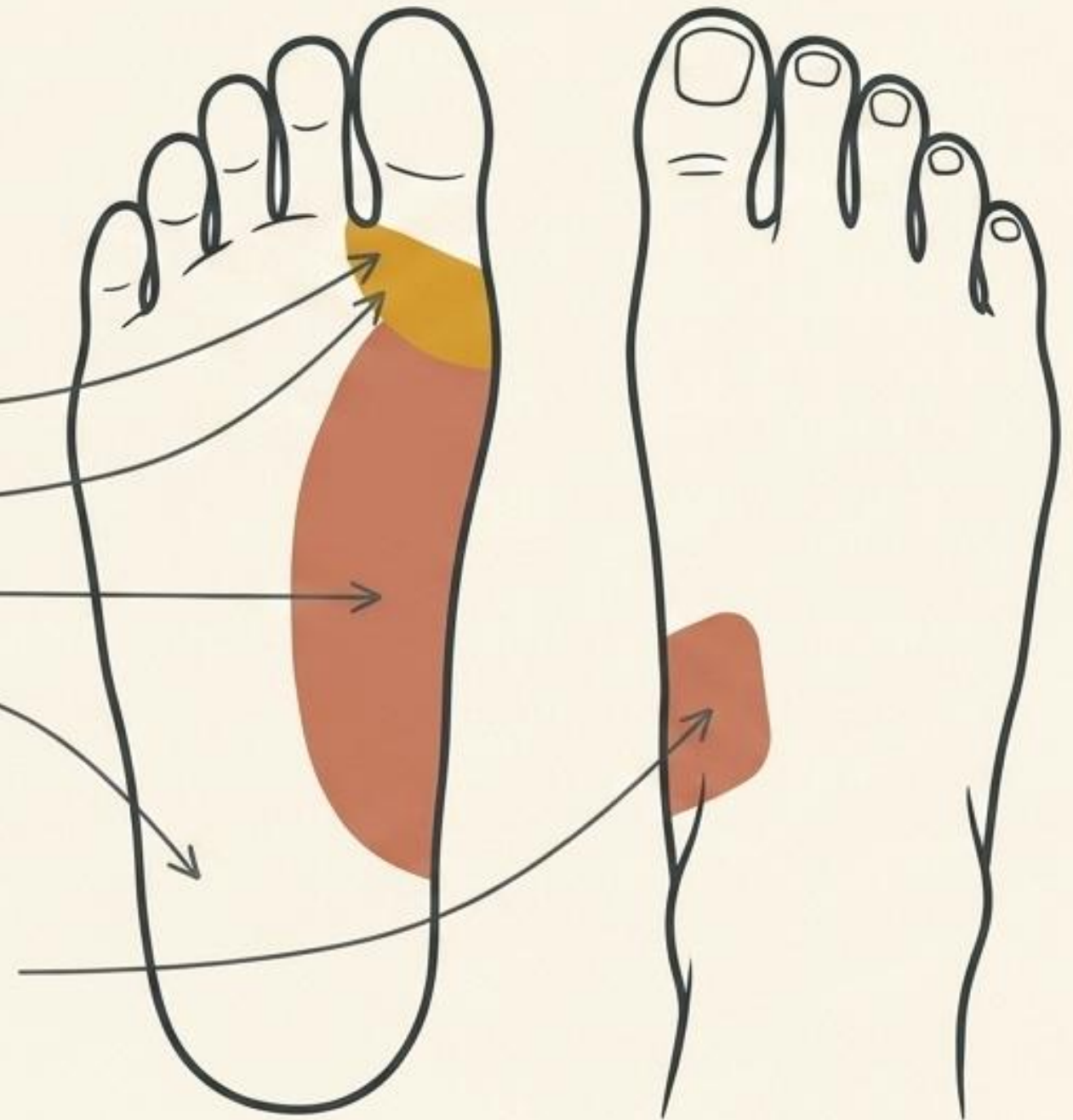
Zones Réflexes Podales

Face Plantaire :

- Pôle inférieur : Hauteur L3/L4, aplomb des 1er et 2ème orteils (bord antérieur du talon).
- Pôle supérieur : Hauteur Th12.
- Glande Surrénale : Au sommet du pôle supérieur.
- Hile : Concavité médiale, hauteur L1.

Face Dorsale :

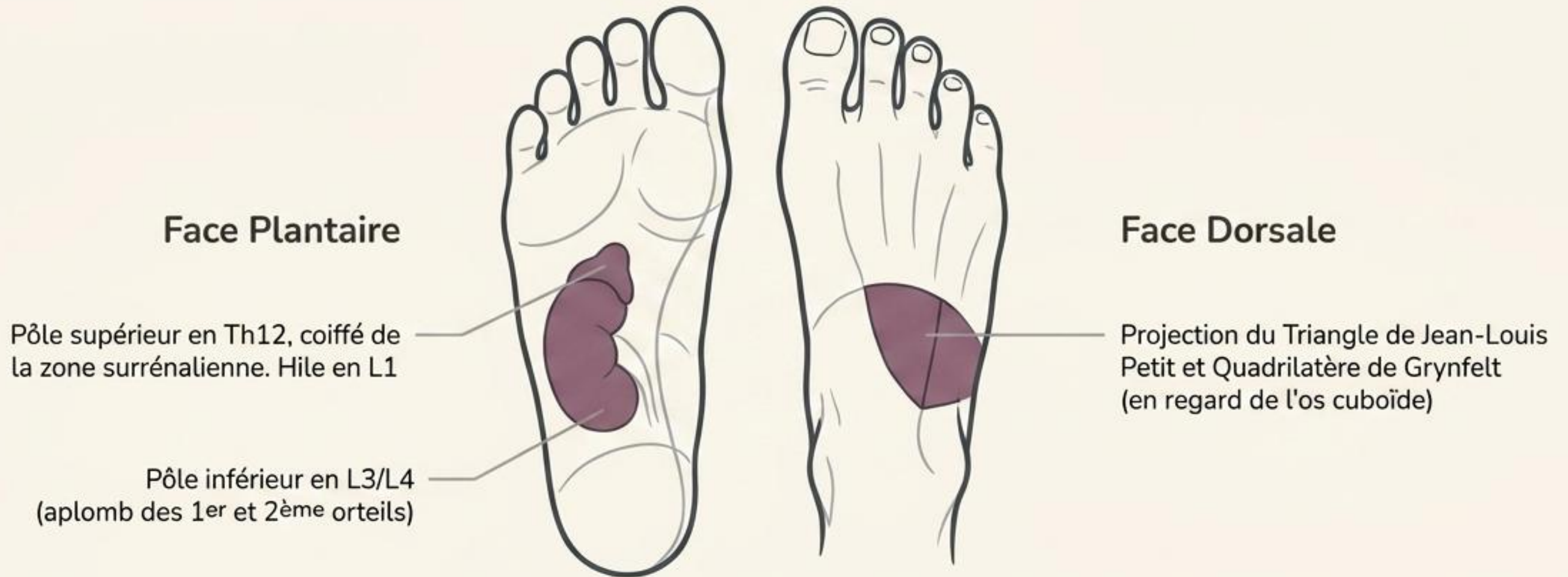
- Os cuboïde : Point réflexe correspondant aux zones de faiblesse postérieure (Grynfelt / Jean-Louis Petit).



Manœuvre Combinée (Test de Mobilité) :

Orientation des pouces en tenaille (face dorsale et plantaire). Suivre l'excursion tissulaire induite par la respiration : caudale à l'inspiration, céphalique à l'expiration.

Cartographie ROP : Zones Réflexes Podales



La Manœuvre Combinée

- Un pouce plantaire, un pouce dorsal.
- Suivre la respiration (descente caudale à l'inspiration) pour tester la mobilité viscérale.

Cartographie ROP et manœuvres réflexes

Face Plantaire

- Pôle inférieur : L3/L4, aplomb des 1^{er}/2^e orteils.
- Pôle supérieur : Th12.
- Surrénale : Sommet du pôle supérieur.
- Hile : L1 (bord médial concave).



Face Dorsale

- Zones de faiblesse (Petit / Grynfeld) situées en regard de l'os cuboïde.



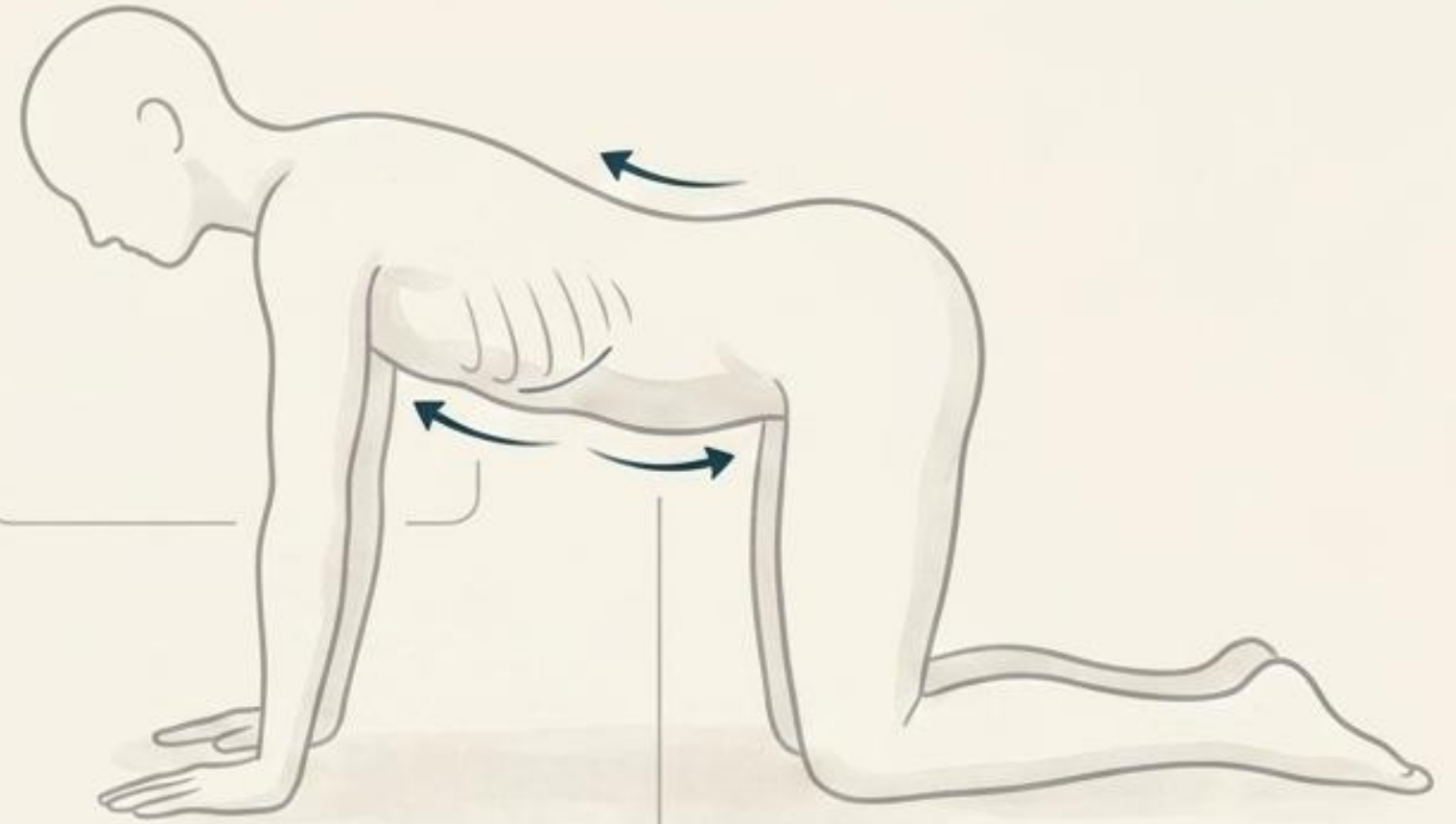
Manœuvre Combinée

- Pouce plantaire + pouce dorsal en regard.
- Test de mobilité : suivre le rein en direction caudale (inspiration) et céphalique (expiration).
 - Balance limbique : Un pouce sur le rein, un pouce sur le cerveau limbique.

Recommandations et Autocorrection

● Hygiène de Vie

- **Hydratation** : Boire souvent, mais en petites quantités.
- **Nutrition** : Limiter les protéines animales le soir pour alléger le travail de filtration.
- **Sommeil** : Privilégier le décubitus latéral gauche pour diminuer les contraintes veineuses (pince aorto-mésentérique).



● Exercices Mécaniques

- **Respiration quadrupédique** : Inspirer en relâchant le ventre, expirer en le rentrant, pour mobiliser la loge rénale.
- **Automassage lombaire** : En décubitus dorsal genoux pliés, engager les pouces dans le quadrilatère de Grynfelt (sous la 12ème côte) et repousser doucement les reins vers l'avant lors de légères inclinaisons latérales.

Conseils Thérapeutiques au Patient



1. Hydratation et Nutrition

Boire de petites quantités régulièrement. Limiter strictement les protéines animales (viande rouge, fromages) et les graisses le soir pour réduire l'acidose.



2. Repos et Posture

Privilégier le décubitus latéral gauche pour dormir, afin de libérer les contraintes veineuses (particulièrement recommandé lors des lombalgies gravidiques).



3. Respiration

Position quadrupédique : inspirer en relâchant le ventre, expirer en le rentrant (répétitions pour mobiliser l'aspiration diaphragmatique).



4. Auto-Mobilisation

Décubitus dorsal, jambes pliées. Enfoncer les pouces entre la 12e côte et la crête iliaque (quadrilatère de Grynfeldt). Incliner les genoux à 45° de part et d'autre pour repousser les reins ventralement.